TÓM TẮT LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 5 Bệnh glaucoma

Tóm tắt từ bài giảng 5. Glaucoma - Diagnosis & Treatment.pdf (19 trang) · Giữ ý chính và dấu hiệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. SINH LÝ THỦY DỊCH VÀ NHÃN ÁP
2. ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI
3. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG
4. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ
5. GLAUCOMA BẨM SINH

1. SINH LÝ THỦY DỊCH VÀ NHÃN ÁP

- **Sản xuất:** biểu mô ở **nếp thể mi**.
- **Lưu thông: hậu phòng → lỗ đồng tử → tiền phòng**.
- **Thoát lưu: góc tiền phòng → lưới bè → ống Schlemm → tĩnh mạch thượng củng mạc**.
- **Vai trò:** tạo nhãn áp, quang học, nuôi dưỡng.
- **Công thức Goldmann: Pio = D × R + Pv** (Pio: nhãn áp; D: tốc độ sản xuất thủy dịch; R: trở lưu thủy dịch; Pv: áp lực tĩnh mạch thượng củng mạc).
- **Nhãn áp bình thường 10–21 mmHg**. **Đa số tăng nhãn áp do tăng R**. Nhãn áp **dao động, cao vào nửa đêm / sáng** → cần **đo nhiều lần trong ngày**.
- **Nhãn áp kế:** nguyên lý **đè bẹt** (Goldmann, Maclakov); nguyên lý **ấn lõm** (Schiotz).

2. ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÂN LOẠI

- Glaucoma là **nguyên nhân gây mù đứng hàng thứ 2**; **> 66,8 triệu người mắc** (năm 2000).
- Đặc điểm chung: **tăng nhãn áp quá mức chịu đựng của mắt**; **lõm và teo gai thị**; **tổn hại thị trường** nghiêm trọng.

Loại	Đặc điểm
Nguyên phát	Không kèm bệnh lý khác; thường **2 mắt**, có tính **di truyền**
Thứ phát	Kèm bệnh mắt / toàn thân, **do thuốc**; thường **1 mắt**
Bẩm sinh	Sơ sinh, **bất thường góc**; sợ sáng, chảy nước mắt
Tuyệt đối	**Không đáp ứng điều trị**; mất thị lực, đau nhức nhiều

3. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC ĐÓNG

- **Yếu tố nguy cơ: châu Á** (Mông Cổ, Việt Nam), da đen; **nữ >> nam**; lớn tuổi; **tiền phòng nông, góc hẹp, viễn thị, trục nhãn cầu ngắn**; tiền căn gia đình.
- **Yếu tố thúc đẩy: căng thẳng (stress), lạnh, thuốc giãn đồng tử**.
- **Cơ chế:** chân mống mắt áp sát, **đóng góc tiền phòng** → thủy dịch không thoát được.
- **Cơ năng: đỏ, đau, nhìn mờ**; **thấy quầng màu sắc**; **buồn nôn, nôn ói**; hoa mắt.
- **Thực thể:** giảm thị lực, **nhãn áp cao**; **soi góc: đóng góc**; **cương tụ rìa**; **giác mạc phù**; **tiền phòng nông**; **đồng tử giãn méo, PXAS (–)**; gai thị cương tụ / lõm teo.
- **Nội khoa** (cắt cơn cấp, **bảo vệ mắt còn lại**, tạm thời chờ phẫu thuật):
  - Toàn thân: **ức chế CAIs**, truyền **Mannitol 20%** (ưu trương), giảm đau, an thần.
  - Tại chỗ: **β-bloquant**, **α-agonist**, **Pilocarpin**, kháng viêm steroid.

- **Ngoại khoa: laser YAG cắt mống chu biên**, **phẫu thuật cắt bè củng mạc**.

4. GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ

- **Yếu tố nguy cơ: da đen >> da trắng**; nữ >> nam; lớn tuổi; **người ruột thịt mắc → nguy cơ gấp 5–6 lần**; nhãn áp khởi điểm cao, dao động; **giác mạc trung tâm mỏng**; PEX.
- **Cơ chế:** trở ngại lưu thông thủy dịch ở **vùng bè** (chưa rõ).
- **Cơ năng: âm thầm, tiến triển chậm**, thường **2 mắt**; **mờ từ từ, không đỏ, không đau**.
- **Thực thể:** nhãn áp cao, dao động; **soi góc: góc mở**; soi đáy mắt: **lõm teo gai**, mạch máu đi về phía mũi, **C/D ≥ 0,5**.
- **Nội khoa (chủ lực):**
  - Đầu tay: **Prostaglandin (Latanoprost)** → **hạ nhãn áp 30–50%**.
  - **Ức chế β (Timolol)**: lưu ý **hen suyễn, bệnh tim mạch**.
  - Cường α / CAIs: phối hợp khi cần.
- **Ngoại khoa: tạo hình vùng bè bằng laser Argon**, **cắt bè củng mạc**, **đặt valve**; chỉ dùng khi **nội khoa kém hiệu quả** hoặc **bệnh nhân không tuân thủ**.

5. GLAUCOMA BẨM SINH

- **Tam chứng: sợ sáng, chảy nước mắt, co quắp mi**.
- Thực thể: **mắt to (buphthalmos)**, đục giác mạc, **đường kính giác mạc > 10 mm**.
- Bệnh sinh: **bất thường màng Barkan**, bất thường cấu trúc góc tiền phòng.
- Điều trị: nội khoa ít tác dụng; **phẫu thuật mở bè (goniotomy) là chủ yếu**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 5. Glaucoma - Diagnosis & Treatment.pdf khi cần chi tiết.